



**KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA
NOMOR : 104.4/I-KEP/DIR/II/2026**

**TENTANG
PEMBENTUKAN KOMITE PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN INFEKSI**

DIREKTUR RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya meningkatkan mutu dan pelayanan Komite Pencegahan dan Pengendalian Infeksi Rumah Sakit Prima Husada, maka diperlukan penyelenggaraan pengorganisasian dan pelayanan Komite Pencegahan dan Pengendalian Infeksi yang bermutu tinggi;
- b. bahwa agar pelayanan pencegahan dan pengendalian infeksi dapat terlaksana dengan baik, perlu adanya Peraturan Direktur tentang kebijakan Pembentukan Komite Pencegahan dan Pengendalian Infeksi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam a dan b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Direktur Rumah Sakit Prima Husada;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien;
4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2017 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (PPI) di Fasyankes;
5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2018 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di Fasyankes;
6. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/413/2020 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian COVID-19;
7. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/1596/2024 tentang Standar Akreditasi Rumah Sakit;
8. Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Nomor HK.02.02/D/47104/2024 tentang Instrumen Survei Akreditasi Rumah Sakit;
9. Keputusan Direktur Perseroan Terbatas Disa Prima Medika Nomor: 263/DPM/I-KEP/DIR/II/2025 tentang Pengangkatan Direktur Rumah Sakit Prima Husada Malang;
10. Keputusan Direktur Perseroan Terbatas Disa Prima Medika Nomor 1042.92/DPMI-KEP/DIR/IX/2025 tentang Pengangkatan PLT Direktur Rumah Sakit Prima Husada Malang.

MEMUTUSKAN ;

- Menetapkan : **KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA TENTANG
PEMBENTUKAN KOMITE PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN INFEKSI**
- Kesatu : Daftar anggota Komite Pencegahan dan Pengendalian Infeksi RS Prima Husada sebagaimana tercantum dalam lampiran I keputusan ini.
- Kedua : Kriteria, uraian tugas, tanggung jawab, dan wewenang komite PPI sebagaimana dimaksud dalam Diktum kedua tercantum dalam lampiran II keputusan ini.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.



- Keempat : Keputusan ini dapat dilakukan perubahan jika diperlukan.
- Kelima : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Direktur Rumah Sakit Prima Husada Nomor 310/I-KEP/DIR/III/2022 tentang Pembentukan Komite Pencegahan dan Pengendalian Infeksi dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 4 Februari 2026
PLT Direktur Rumah Sakit Prima Husada,

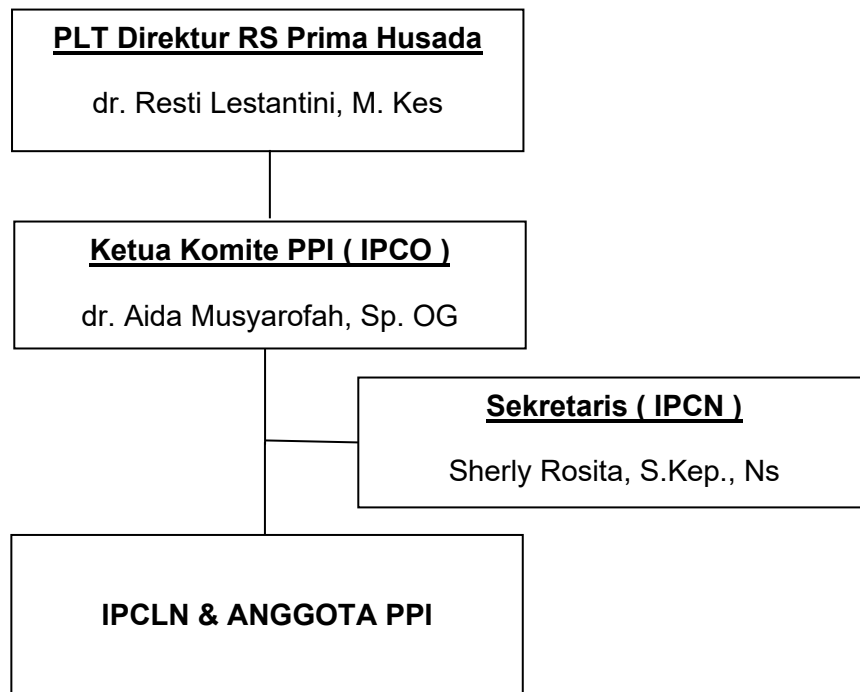


dr. Resti Lestantini, M. Kes



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT PRIMA
HUSADA
NOMOR : 104.4/I-KEP/DIR/II/2026
TENTANG
PEMBENTUKAN KOMITE PENCEGAHAN DAN
PENGENDALIAN INFEKSI

STRUKTUR ORGANISASI DAN DAFTAR ANGGOTA KOMITE PENCEGAHAN DAN
PENGENDALIAN INFEKSI



Daftar Anggota :

- | | |
|--|--|
| 1. Ketua Komite PPI (IPCOC) | : dr. Aida Musyarofah, Sp. OG |
| 2. Sekretaris (IPCN) | : Sherly Rosita, S.Kep., Ns |
| 3. Anggota (IPCLN dan Anggota Komite PPI Lainnya): | |
| a. IPCLN IRJA | : Yuni Novita, A.Md.Kep |
| b. IPCLN IRJA | : Raysa Rosadilla, A.Md.Kep |
| c. IPCLN IGD | : Tiara Anggita Putri, S.Tr.Kep., Ns |
| d. IPCLN IKO | : Eko Pambudi, AMd.Kep |
| e. IPCLN NICU & Neonatologi | : Rismaya Felantriardianti, S.Kep., Ns |
| f. IPCLN ICU | : Tatik Widayati, S.Kep., Ns |
| g. IPCLN HCU | : Lusianah Nurul I, A.Md.Kep |
| h. IPCLN IRNA 2A | : Wahlah, S.Kep., Ns |
| i. IPCLN IRNA 2C | : Neni Novitasari, A.Md.Kep |
| j. IPCLN IRNA 3A | : Anis Nurlaili, S.Kep., Ns |
| k. IPCLN IRNA 3C | : Diyah Purwanti, S.Kep., Ns |
| l. IPCLN PICU | : Resa Novitasari, A.Md.Kep |
| m. IPCLN IRNA 4A | : Firda Ayu Maghfiroh, S.Tr.Kep., Ns |
| n. IPCLN IRNA 5C | : Laras Wieny Nuriska, A.Md.Kep |
| o. IPCLN IRNA 6A | : Purwinda Respati P, A.Md.Kep |
| p. IPCLN IRNA 7A | : Trikaya Inggar Yuniar, A.Md.Kep |
| q. IPCLN IRNA 8A | : Tri Ani Darma W, A.Md.Kep |
| r. Maternitas | : Uswatul Chorida, A.Md.Keb |
| s. Instalasi Gizi | : Veni Lestari Puri P, A.Md.Gz |
| t. IFRS | : Pipin Purwa Ningrum, S.Farm., Apt |



u. Pengadaan Farmasi	: Yeny Imas Christiana, S.Farm., Apt
v. Instalasi Laboratorium	: Yoga Eka Ramadani Ariwa, A.Md.AK
w. Instalasi Radiologi	: Erwin Prasetyo Aji, A.Md.Rad
x. IPSRS & K3RS	: Faisal Aminuddin Ilham, S.KM
y. CSSD	: Ahmad Taufan Fauzi, A.Md.Kep
z. Laundry	: Salma Taris Ma'ula
aa. Rekam Medis	: Nurmayanti Sekar Wulan, A.Md.RMIK
bb. Asuransi Center	: Ayu Lestari Floresa Nur R. A.Md.Aktr
cc. CS & Umum	: Putri Wahyuning Gusti
dd. Kamar Jenazah	: Alifia Ahmad Ageng

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 4 Februari 2026
PLT Direktur Rumah Sakit Prima Husada,



dr. Resti Lestantini, M. Kes



LAMPIRAN II
KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT PRIMA
HUSADA
NOMOR : 104.4/I-KEP/DIR/II/2026
TENTANG
PEMBENTUKAN KOMITE PENCEGAHAN DAN
PENGENDALIAN INFEKSI

KRITERIA, URAIAN TUGAS, TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG

A. DIREKTUR RUMAH SAKIT

Kriteria :

1. Tenaga medis / tenaga kesehatan / tenaga profesional lainnya.
2. Memiliki kompetensi manajemen rumah sakit.
3. Memiliki kemampuan leadership.
4. Warga Negara Indonesia.
5. Bukan pemilik dari rumah sakit tersebut.

Uraian Tugas :

1. Menentukan kebijakan pengendalian dan pencegahan infeksi di rumah sakit.
2. Membentuk Komite PPIRS dengan Surat Keputusan.
3. Mengadakan evaluasi kebijakan pencegahan dan pengendalian infeksi nosokomial berdasarkan saran dari Komite PPIRS.

Tanggung Jawab :

1. Bertanggung jawab menyediakan fasilitas, sarana prasarana dan anggaran yang cukup untuk pengendalian infeksi di rumah sakit.
2. Bertanggung jawab dan memiliki komitmen yang tinggi terhadap penyelenggaraan upaya pencegahan dan pengendalian infeksi nosokomial.

Wewenang :

1. Mengangkat dan memberhentikan ketua Komite PPIRS dengan surat keputusan direktur.
2. Dapat menutup suatu unit perawatan atau Unit yang dianggap potensial menularkan penyakit untuk beberapa waktu sesuai kebutuhan berdasarkan saran dari Tim PPIRS.
3. Mengesahkan Standar Prosedur Operasional (SPO) untuk PPIRS.

B. KETUA KOMITE PPI (IPCO / *Infection Prevention and Control Officer*)

Kriteria IPCO:

1. Ahli atau dokter yang mempunyai minat dalam PPI.
2. Mengikuti pendidikan dan pelatihan dasar PPI.
3. Memiliki kemampuan leadership.

Uraian Tugas :

1. Berkontribusi dalam diagnosis dan terapi infeksi yang benar.
2. Menyusun pedoman surveilans HAIs di Rumah Sakit.
3. Mengidentifikasi dan melaporkan kuman patogen dan pola resistensi antibiotika.
4. Bekerjasama dengan perawat PPI memonitor kegiatan surveilans infeksi dan mendeteksi serta menyelidiki KLB.
5. Membimbing dan mengajarkan praktik dan prosedur PPI yang berhubungan dengan prosedur terapi.
6. Turut memonitor cara kerja tenaga kesehatan dalam merawat pasien.
7. Turut membantu semua petugas kesehatan untuk memahami pencegahan dan pengendalian infeksi.



Tanggung jawab :

1. Bertanggung jawab terhadap evaluasi, rekomendasi dan tindak lanjut program dengan melaksanakan pertemuan dan pelaporan berkala setiap 3 bulan.
2. Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan penyelidikan sewaktu ada indikasi kejadian luar biasa di Rumah Sakit dan mengevaluasi efektivitas dan dampak dari kebijakan pengendalian infeksi, prosedur dan peralatan.
3. Bertanggung jawab terhadap penyusunan dan evaluasi pelaksanaan program PPI dan program Pendidikan dan pelatihan PPI.

Wewenang :

1. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan direktur tentang pengendalian infeksi di rumah sakit.

C. SEKRETARIS KOMITE PPI (IPCN / *Infection Prevention and Control Nurse*)

Kriteria IPCN:

1. Perawat dengan pendidikan min S1 dan memiliki sertifikasi PPI.
2. Memiliki komitmen di bidang pencegahan dan pengendalian infeksi.
3. Memiliki pengalaman sebagai kepala ruangan atau setara.
4. Memiliki kemampuan leadership, inovatif, dan confident.
5. Bekerja penuh waktu.

Uraian Tugas :

1. Mengunjungi ruangan setiap hari untuk memonitor kejadian infeksi yang terjadi di lingkungan kerjanya, baik rumah sakit dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya.
2. Memonitor pelaksanaan PPI, penerapan SPO, kewaspadaan isolasi.
3. Melaksanakan surveilans infeksi dan melaporkan kepada Komite PPI.
4. Melakukan investigasi terhadap KLB dan Bersama-sama Komite PPI memperbaiki kesalahan yang terjadi.
5. Memonitor kesehatan petugas kesehatan untuk mencegah penularan infeksi dari petugas kesehatan ke pasien atau sebaliknya.
6. Audit pencegahan dan pengendalian infeksi termasuk terhadap limbah, laundry, gizi, dan lain-lain dengan menggunakan daftar tilik. Memonitor kesehatan lingkungan .
7. Memonitor terhadap pengendalian penggunaan antibiotika yang rasional.
8. Mendesain, melaksanakan, memonitor dan mengevaluasi surveilans infeksi yang terjadi di rumah sakit dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya.
9. Memberikan motivasi dan teguran tentang pelaksanaan kepatuhan PPI.
10. Mempraktikkan penyuluhan bagi petugas kesehatan, pengunjung dan keluarga tentang topik infeksi yang sedang berkembang di masyarakat, infeksi dengan insiden tinggi.

Tanggung Jawab:

1. Bersama Komite PPI melakukan pelatihan petugas kesehatan tentang PPI di rumah sakit dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya.
2. Bersama Komite menganjurkan prosedur isolasi dan memberikan konsultasi tentang pencegahan dan pengendalian infeksi yang diperlukan pada kasus yang terjadi di rumah sakit.
3. Memberikan saran desain ruangan rumah sakit agar sesuai dengan prinsip PPI.
4. Meningkatkan kesadaran pasien dan pengunjung rumah sakit tentang PPI.
5. Sebagai koordinator antara departemen/unit dalam mendeteksi, mencegah dan mengendalikan infeksi di rumah sakit.

Wewenang :

1. Mengumpulkan data.



2. Memberikan teguran / peringatan terhadap kesalahan dalam pencegahan dan pengendalian infeksi.
3. Membuat laporan surveilans dan melaporkan ke Komite PPI.

D. IPCLN / Infection Prevention and Control Link Nurse

Kriteria IPCLN:

1. Perawat dengan pendidikan min D3 dan memiliki sertifikasi PPI.
2. Memiliki komitmen di bidang pencegahan dan pengendalian infeksi.
3. Memiliki kemampuan leadership.

Uraian Tugas IPCLN

IPCLN sebagai perawat pelaksana harian/penghubung bertugas:

1. Menginput surveilans setiap pasien di unit rawat inap masing-masing kedalam SIMRS.
2. Memberikan motivasi dan teguran tentang pelaksanaan kepatuhan pencegahan dan pengendalian infeksi pada setiap personil ruangan di unit rawatnya masing-masing.
3. Memberitahukan kepada IPCN apabila ada kecurigaan adanya infeksi nosokomial pada pasien.
4. Berkoordinasi dengan IPCN saat terjadi infeksi potensial KLB, penyuluhan bagi pengunjung di ruang rawat masing-masing konsultasi prosedur yang harus dijalankan bila belum faham.

Tanggung Jawab

1. Memberitahukan kepada IPCN apabila ada kecurigaan adanya infeksi nosokomial pada pasien.

Wewenang

1. Memberikan motivasi dan teguran tentang kepatuhan pelaksanaan PPI pada setiap personil ruangan di unit rawatnya masing – masing
2. Memonitor kepatuhan petugas kesehatan yang lain dalam menjalankan standar isolasi.

E. ANGGOTA KOMITE PPI

Kriteria Anggota Komite PPI

1. Mempunyai minat dalam PPI.
2. Pernah mengikuti pendidikan dan pelatihan dasar PPI.

Uraian Tugas

1. Menetapkan definisi infeksi terkait layanan kesehatan.
2. Membuat strategi / program menangani risiko PPI.
3. Proses pelaporan.
4. Melaksanakan sosialisasi kebijakan PPIRS, agar kebijakan dapat dipahami dan dilaksanakan oleh petugas kesehatan rumah sakit.
5. Membuat SPO PPI.
6. Melakukan pertemuan berkala, termasuk evaluasi kebijakan.
7. Berkoordinasi dengan unit terkait lain.
8. Mengembangkan, mengimplementasikan dan secara periodik mengkaji kembali rencana manajemen PPI apakah telah sesuai kebijakan manajemen rumah sakit.
9. Melakukan pengawasan terhadap tindakan-tindakan yang menyimpang dari standar prosedur/ monitoring surveilans proses.

Tanggung Jawab

1. Metode pengumpulan data (surveilans).



2. Turut menyusun kebijakan clinical governance dan patient safety.
3. Melakukan investigasi, menetapkan dan melaksanakan penanggulangan infeksi bila ada KLB di rumah sakit dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya.
4. Memberikan masukan yang menyangkut konstruksi bangunan dan pengadaan alat dan bahan kesehatan, renovasi ruangan, cara pemrosesan alat, penyimpanan alat dan linen sesuai dengan prinsip PPI.

Wewenang Komite PPI

1. Memberi usulan untuk mengembangkan dan meningkatkan cara pencegahan dan pengendalian infeksi.
2. Memberikan konsultasi pada petugas kesehatan rumah sakit dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya dalam PPI.
3. Mengusulkan pengadaan alat dan bahan yang sesuai dengan prinsip PPI dan aman bagi yang menggunakan.
4. Mengusulkan pengadaan alat dan bahan yang sesuai dengan prinsip PPI dan mana bagi yang menggunakan\Mengidentifikasi temuan di lapangan dan mengusulkan pelatihan untuk meningkatkan kemampuan sumber daya manusia (SDM) rumah sakit dalam PPI.
5. Memberikan usulan kepada Direktur untuk pemakaian antibiotika yang rasional di rumah sakit berdasarkan hasil pantauan kuman dan resistensinya terhadap antibiotika dan menyebarluaskan data resistensi antibiotika.
6. Menentukan sikap penutupan ruangan rawat bila diperlukan karena potensial menyebarkan infeksi.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 4 Februari 2026
PLT Direktur Rumah Sakit Prima Husada,



dr. Resti Lestantini, M. Kes